

Fecha Última Actualización: 14-08-2024 17:21:56

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Margarita Del Carmen Carrillo Muñoz
Edad : 55a 7m 13d
Dirección : Lingue 640

Rut : 10.009.960-8
Fecha Nacto: 01/01/1969
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1406554
Sexo : Femenino
Teléfono : 984709995

N° Epicrisis
405734

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 17/06/2024 12:40

Días Estadía: 58

Unidad de Egreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad

Fecha Egreso : 14/08/2024 17:08

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Dolor abdominal

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Paciente 55 años con los siguientes antecedente:

AM: Esquizofrenia en controles habituales por Salud Mental HSR, en general buen control, Retraso mental moderado, Hipotiroidismo, Diabetes NIR
Aparentemente sin antecedentes quirúrgicos
Sociales: Institucionalizada desde los 6 años por falta de red familiar. Padre alcoholico
Fármacos:

- Olanzapina 0-0-3 VO
 - Lorazepam 1-1-1 VO
 - Ácido valproico 250 mg 1/2 - 0 - 1/ 2 VO
 - Metformina 850 mg 0-1-0
 - Levotiroxina 75 ug 1-0-0
- Alergias: no

Historia actual:

No se cuenta con historia de cuidador. Aparentemente un par de semanas de evolución de dolor abdominal, se desconoce tránsito intestinal. Es traída a urgencia en malas condiciones, con dolor abdominal, en gasping, desaturando, cianótica, hipotensa (60/30), bradicárdica y mal perfundida, soporosa, HGT 120, abdomen distendido, timpánico. Se intuba y se apoya con NE 0.4 y ADN 0.3, mejorando perfusión clínica. Laboratorio pH 6.9, Co2 73, ascenso de PCR, leucopenia, Hcto 54%.

TC TAP destaca: Condensaciones basales en ambos pulmones, Distensión esofágica con contenido alimentario. Sobredistensión gástrica con contenido alimentario. Dilatación difusa de asas de intestino delgado y grueso, sin reconocer cambio de calibre abrupto. Abundante contenido estercoráceo en el colon, especialmente en el recto y colon sigmoides. No se reconocen áreas de isquemia transmural. Mínimo líquido libre pelviano, sin neumoperitoneo.

Ingresa a pabellon de urgencia grave. LMSIU, se evidencia escaso liquido libre turbio, gran distension de asas, colon izquierdo desde sigmoides necrotico, gran fecaloma en recto. Se decide resección de colon izquierdoy cierre de cabos. Se envía biopsia de colon, se decide mantener laparostomizada con abthera en protocolo de reanimacion intestinal. Se instala drenaje jackson pratt en fosa iliaca derecha. Se realiza vasciamento de fecaola via transanal, se describe salida de clips para papel. Durante

Fecha Epicrisis : 14/08/2024 17:21

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 14-08-2024 17:21:56

Página 2 de 4

pabellón además se describe NE 0.3 y ADN 0.3, hipoglicemia hasta 36 y aspiración abundante de contenido fecaloideo desde sonda nasogástrica. Sin diuresis desde ingreso.

Se traslada grave a UCI, evoluciona en muy malas condiciones, con vasoactivos en ascenso hasta 0.7 NE y ADN 0.4. Lactato 155.

Ingresa mal perfundida, fría a distal, CRT 5 segundos, sin livideces. Sedada, isocórica, sin lesiones cutáneas. Ventila de forma simétrica, buena mecánica pulmonar al ventilador, aspiración de contenido fecaloideo franco desde TOT. Ritmo sinusal al monitor, FC inapropiada para contexto hemodinámico (60 lpm). Abdomen -> laparostomía contenida con abthera, con infusión de 400 ml/hr de solución de diálisis peritoneal. Impresiona abdomen distendido.

A la ecoscopia corazón con buena contractilidad (Vti 14) con insuficiencia crónótropa, VEC contraído.

Diagnósticos de ingreso:

- Shock séptico de foco abdominal
- Obstrucción intestinal por fecaloma / cuerpo extraño
- Colectomía izquierda, cabos cerrados
- Laparostomía contenida con abthera
- Neumonía aspirativa
- Falla renal aguda

Evolucion en UCI 17/6/24 al 30/6/24:

Hemodinamia: requirió tres DVAs, volemicación, corticoides dosis de estrés y HFAV, en contexto de FOM 2da a shock séptico, disminución progresiva de DVA. Adrenalina y vasopresina suspendidas 20/06, noradrenalina suspendida 21/06. Última ecoscopia registrada de 29/06 con adecuada contractilidad. En UCI se inicia captopril por tendencia a la hipertensión, cambio por losartan.

Respiratorio: VMI por shock séptico/FOM, 17/06-27/06, con salida a CNAF del cual se desteta el 29/06. Actualmente se mantiene con FiO2 ambiental, sin conflicto ventilatorio.

Infectológico: shock séptico foco abdominal (foco primario) y pulmonar (neumonía aspirativa).

CAET con Strepto agalactiae, enterobacter cloacae complex y SAMS, tratado con tazonam, completado el 27/06. Además, CAET de la misma fecha con cultivo hongos (+) candida albicans, se decide tratar con fluconazol por 7 días (hoy 6/7)

Nuevo CAET el 25/06 (+) para Stenotrophomonas maltophilia MS y candida albicans, se inicia tratamiento con cotrimoxazol (28/06). TAC foco de condensación de LID

Buena respuesta, PPII a la baja.

Quirúrgico: en seguimiento por UTU.

17/06 cirugía abdominal, retiro de fecaloma extenso rectal por vía anal y colectomía izquierda con cierre en colon sigmoidees medio y colon transversal distal; laparotomía contenida con abthera e irrigación peritoneal, 19/06 2° cirugía abdominal, colostomía y cierre.

28/06 se retira dje JP. TAC AP (25/06) sin complicaciones abdomino-pélvicas.

Renal/MI: ingresa con falla renal aguda oligúrica. Apoyada con 24 hrs de conexión a HFAV (18/06) adecuada respuesta.

Evolución posterior hacia la mejoría espontánea de la función renal, presentando hipernatremia que se ha ido corrigiendo con aportes de agua libre.

30/06/24

Intermedio quirúrgico:

Microbiología:

03/07 (P) HC I y II

25/06 CAET S. Maltophilia + candida albicans

25/06 GDH y Toxinas (-)

17/06 HCs negativos

17/06 CAET Strepto agalactiae, enterobacter cloacae complex y SAMS

CAET Cultivo de hongos (+) Candida

Antibioticoterapia:

Fecha Epicrisis : 14/08/2024 17:21

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 14-08-2024 17:21:56

Página 3 de 4

Levofloxacin FI 03/07

Tazonam \$ Fluconazol \$ Cotrimoxazol \$

Tiempos quirúrgicos:

17/06 Hemicolectomía izquierda + Abthera y reanimación intestinal

19/06 Colectomía transversa + Colostomía terminal + Cierre de pared

TC Tórax 04/07

Focos de relleno alveolar bilaterales que predominan en ambos lóbulos inferiores, con componente atelectásico, compatibles con focos de neumopatía inflamatoria - infecciosa en evolución. En el diagnóstico diferencial considerar como primera posibilidad un origen aspirativo.

Leve derrame pleural izquierdo.

Laboratorio:

07/07: Ac lactico 15.6, amonio 0.65, alb 2.3, Ca 9, crea 0.56, BUN 27.9, P 3.8, Mg 1.8, PCR 37.4, hto 30.3, hb 9, leucos 12.980 (11.450), RAN 9.900, plaquetas 849.000 (949.000), Na 136, K 4.86, Cl 104, pH 7.3, HCO3 24.6

Evoluciona favorablemente, se logra estad basal de conciencia por aporte de historia de cuidadora, buena evolucion con fonoaudiologia, logra alimentarse por boca sin complicaciones, diuresis + deposiciones por colostomia. Ostomia vital. Herida operatoria con dehiscencia a distal y secrecion escasa que puede continuar con curaciones diarias.

En este contexto, conversado previamente con cuidador, se decide alta médica.

Diagnóstico de Egreso

SEPSIS, NO ESPECIFICADA -

OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES Y LAS NO ESPECIFICADAS -

OTRAS NEUMONIAS BACTERIANAS - aspirativa

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J: NO

Evoluciona favorablemente, se logra estad basal de conciencia por aporte de historia de cuidadora, buena evolucion con fonoaudiologia, logra alimentarse por boca sin complicaciones, diuresis + deposiciones por colostomia. Ostomia vital. Herida operatoria con dehiscencia a distal y secrecion escasa que puede continuar con curaciones diarias.

En este contexto, conversado previamente con cuidador, se decide alta médica con hospitalización domiciliaria para kinesiterapia y continuar con rehabilitación motora

Plan Post Alta

1) Reposo relativo en casa, caminar. Kinesiterapia motora.

2) Regimen papilla

4) Cuidados de ostomia

5) Continuar con medicamentos de base indicados por psiquiatria y por endocrino:

- Olanzapina 0-0-3 VO

- Lorazepam 1-1-1 VO

- Ácido valproico 250 mg 1/2 - 1/2 - 1/2 VO

- Metformina 850 mg 0-1-0

- Levotiroxina 75 ug 1-0-0

6) Retomar controles cronicos con tratantes

8) Paracetamol 500 mg 2 comp cada 8 hrs SOS en caso de dolor

9) Control con en poli becados UTU el jueves 5 de septiembre, CDT pasillo 11, a las 12:00 (atención por orden de llegada). Acudir con esta epicrisis.

10) Consultar en urgencias en caso de dolor intenso, fiebre, vomitos, diarrea, enrojecimiento de herida mayor y salida de mas pus, o cuando estime conveniente.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Fecha Epicrisis : 14/08/2024 17:21

Página 3 de 4



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 14-08-2024 17:21:56

Página 4 de 4

Régimen Alimentario : Papilla

Medicamentos :

Controles

Francisco Jamis Arzani

INTERNO

Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 14/08/2024 17:21

Página 4 de 4

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:04

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar